

فاعلية التدخل المهني في الخدمة الاجتماعية لزيادة  
الكفاءة الاجتماعية لدى المصابات بالرهاب الاجتماعي  
دراسة مطبقة على عينة من طالبات المدارس الثانوية بمدينة جدة  
**The effectiveness of professional intervention in  
to increase social competence social work  
among Female students suffering from social  
phobia**

A study applied to a sample of female secondary school  
students in Jeddah city schools

الباحثة: رانية محمد إبراهيم الرايقي

باحثة دكتوراة كلية اللغات والعلوم الإنسانية قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية

الأستاذ الدكتور: بدر الدين كمال عبده

أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة القصيم

١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ م

### أولاً: مشكلة الدراسة

حظيت الكفاءة الاجتماعية باهتمام واسع من الباحثين في العقود الأخيرة لما تمثله من أهمية بالغة في تحقيق النمو الاجتماعي السليم، ولا سيما في البيئة المدرسية التي تُعد ميداناً حصباً لتشكيل شخصية الطالب وتنمية قدراته الاجتماعية والانفعالية والمعرفية. وتُعد مرحلة التعليم الثانوي من المراحل الحاسمة في حياة الفرد، إذ تتبلور فيها القيم والعادات والاتجاهات، وتتكون خلالها ملامح الشخصية، ويتحدد مسارها النفسي والاجتماعي تبعاً لما توفره البيئة المدرسية من خبرات وعلاقات اجتماعية.

وفي المقابل، يُعد اضطراب الرهاب الاجتماعي من أبرز الاضطرابات النفسية التي تؤثر سلباً في الكفاءة الاجتماعية للأفراد، حيث تشير الدراسات العالمية إلى أن نسب انتشاره تتراوح بين (١٣-١٤%) من عموم السكان، وتصل في بعض الدول إلى أكثر من (٢٠%). كما تشير الدراسات العربية والخليجية إلى أن معدلات الإصابة بالرهاب الاجتماعي قد تكون أعلى من مثيلاتها في المجتمعات الغربية، إذ أظهرت دراسات سعودية حديثة أن نسب انتشار القلق الاجتماعي بين طلبة الجامعات والمدارس تتراوح بين (١٣% و ٣٢%)، وهو ما ينعكس سلباً على الأداء الأكاديمي والتكيف الاجتماعي.

وقد بدأ لدى الباحثة الإحساس بمشكلة الرهاب الاجتماعي أثناء التدريب الميداني بمستشفى الأمل الصحي لعلاج الإدمان بمدينة جدة خلال مرحلة الماجستير، حيث حضرت مجموعة من جلسات العلاج مع المختصين النفسيين والاجتماعيين، شملت عدداً من الجلسات مع صغار المدمنين. ومن خلال متابعة هذه الجلسات والاطلاع على ملفاتهم، لاحظت الباحثة أن مجموعة من المراهقين المدمنين يعانون من مؤشرات واضحة للرهاب الاجتماعي، رغم أن البعض منهم ناجح دراسياً وذو مستوى اجتماعي جيد. وقد قدمت الباحثة خلال مرحلة الماجستير مقياساً مقنناً ومحكماً للكشف عن حجم مشكلة الرهاب الاجتماعي بين طلاب وطالبات المدارس الثانوية كدراسة استباقية لتحليل أسباب المشكلة وفهم آثارها على المدى القصير والطويل.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين المهارات الاجتماعية والرهاب الاجتماعي، فقد طُرحت فرضيتان رئيسيتان لتفسير السلوك الاجتماعي المنكفي؛ حيث تنص الفرضية الأولى على أن الأفراد الذين يعانون من القلق الاجتماعي والحجل يفتقرون إلى المهارات الاجتماعية الأساسية، مما يؤدي إلى ضعف أدائهم الاجتماعي وتعرضهم لخبرات تفاعل سلبية تُفاقم من حدة القلق والانطواء. أما الفرضية الثانية، فتشير إلى أن هؤلاء الأفراد يمتلكون بالفعل مهارات اجتماعية مناسبة، إلا أن القلق المفرط في المواقف الاجتماعية يعيق أدائهم الفعلي، كما أشار إلى ذلك هيمبرج وهولت (Heimberg & Holt, 1997) ووفقاً لهذه الفرضية، فإن مستوى الاستشارة المعتدل قد يُحسن الأداء، بينما تُعوق الاستشارة المفرطة السلوك الاجتماعي السوي.

وقد أظهرت الأدبيات العلاجية أن الأفراد ذوي القلق الاجتماعي يعانون غالبًا من نقص في المهارات الاجتماعية، مما يجعل التدريب على هذه المهارات جزءًا أساسيًا من البرامج العلاجية، إذ يساهم تحسينها في تعزيز التفاعلات الاجتماعية الناجحة وخفض مستويات القلق. وفي المقابل، إذا كان القلق المفرط هو العامل الأساسي المعيق للأداء، فإن العلاج بالتعرض يعد أكثر فاعلية، مما يستدعي الجمع بين التدريب على المهارات الاجتماعية وتقنيات خفض القلق في البرامج العلاجية المتكاملة. وتشير الدراسات إلى أن الأفراد ذوي القلق الاجتماعي يدركون أنفسهم على أنهم أقل مهارة اجتماعية من أقرانهم، ويتجنبون التفاعل البصري والمواقف الاجتماعية، مما يؤدي إلى زيادة التجنب والانسحاب الاجتماعي وتدني القبول الاجتماعي لديهم، لا سيما في مراحل المراهقة.

وتؤكد الملاحظات الإكلينيكية والتربوية أن انخفاض الكفاءة الاجتماعية لدى الطالبات يساهم في زيادة حدة الرهاب الاجتماعي، مما يؤدي إلى تدني تقدير الذات، وضعف التفاعل الاجتماعي، والإخفاق الدراسي. وانطلاقًا من هذه المعطيات النظرية والميدانية، رأت الباحثة أنه هناك حاجة إلى برنامج تدخل مهني في الخدمة الاجتماعية يساهم في تنمية الكفاءة الاجتماعية والحد من مظاهر الرهاب الاجتماعي لدى طالبات المرحلة الثانوية المصابات بالرهاب الاجتماعي

### ثانيًا: أهمية الدراسة

تحتل هذه الدراسة بأهمية خاصة لارتباطها بقضايا نفسية واجتماعية تمس فئة الشباب، حيث تسعى إلى فهم أبعاد الرهاب الاجتماعي وتأثيره على حياتهم، وإلى تعزيز كفاءتهم الاجتماعية بما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتطوير مهاراتهم في التكيف الاجتماعي. وتنطلق أهمية الدراسة من جانبين رئيسين: الأهمية العلمية والأهمية العملية، وذلك على النحو الآتي:

#### الأهمية العلمية

١. يُعد الاهتمام بالشباب وتربيتهم وتعليمهم وإعدادهم لتحمل مسؤولياتهم المستقبلية من القضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام دول العالم، إذ يُقاس مدى تقدم الأمم بما تقدمه من خدمات وبرامج تنموية موجهة لفئة الشباب التي تمثل ما لا يقل عن ثلث عدد السكان. ويُعد هذا الاهتمام مبررًا لتكثيف الجهود المهنية من جانب المتخصصين في العلوم الإنسانية عامة، وفي الخدمة الاجتماعية خاصة، من أجل تمكين الشباب وتنمية قدراتهم الاجتماعية والنفسية.
٢. تستمد هذه الدراسة أهميتها من تناولها أحد الاضطرابات النفسية الاجتماعية الأكثر شيوعًا في العصر الحديث، وهو اضطراب الرهاب الاجتماعي، الذي يمثل قضية ذات أبعاد إنسانية ومجتمعية خطيرة، خصوصًا في المجتمع السعودي كما تشير الإحصاءات الحديثة. وقد أثبتت الدراسات أن الرهاب الاجتماعي اضطراب مزمن في حال إهماله، إذ ينعكس سلبيًا على الأداء اليومي للفرد وجودة حياته، كما قد يؤدي إلى نتائج خطيرة مثل الإدمان أو التفكير الانتحاري، مما يؤكد ضرورة التدخل المبكر والفعال للحد من آثاره.

٣. تكتسب هذه الدراسة أهميتها من تناولها لمفهوم الكفاءة الاجتماعية بوصفها أحد المفاهيم الجوهرية في الخدمة الاجتماعية، كونها تمثل مؤشرًا رئيسًا للنجاح الاجتماعي وجودة الحياة. فتنمية المهارات الاجتماعية لدى الشباب تسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية وتحمل المسؤولية ومواجهة التحديات، بينما يؤدي افتقاد هذه المهارات إلى ضعف الشخصية وصعوبات في بناء العلاقات الاجتماعية والتكيف، مما قد يرتبط بظواهر سلبية كالعزلة والانحراف الاجتماعي.

٤. كما تكمن الأهمية العلمية النظرية للدراسة في بناء إطار نظري متكامل يُبرز أسباب الرهاب الاجتماعي وتأثيراته السلبية، ويُوضح أوجه القصور في الكفاءة الاجتماعية وأساليب اكتسابها، إلى جانب تقديم رؤية علمية تسهم في إثراء الأدبيات العربية في هذا المجال.

### الأهمية العملية

تمثل الأهمية العملية للدراسة في سعي الباحثة إلى تصميم وتقديم برنامج علاجي متكامل يعتمد على استراتيجيات متنوعة من المداخل العلاجية المعرفية والسلوكية والانفعالية، ضمن إطار انتقائي تكاملي يتناسب مع طبيعة المراهقين المصابين بالرهاب الاجتماعي. ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية الكفاءة الاجتماعية والحد من مظاهر الرهاب الاجتماعي، مع التحقق من مدى ملائمة البيئة السعودية وإمكانية تطبيقه ميدانيًا لتحقيق نتائج ملموسة.

كما تأمل الباحثة أن يساهم هذا البرنامج في دعم الممارسين والباحثين والمهتمين بقضايا المراهقين، سواء في المدارس أو المنازل أو المراكز المتخصصة، من خلال توفير نموذج تطبيقي مهني يمكن الاستفادة منه في تصميم برامج علاجية مستقبلية. إضافة إلى ذلك، ستعمل الباحثة على تعديل مقياس الرهاب الاجتماعي الذي أعدته سابقاً في مرحلة الماجستير، وإعداد مقياس جديد للكفاءة الاجتماعية بما يري المكنة العربية بمقاييس علمية رصينة قابلة للتطبيق والقياس.

### ثالثاً: أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى بناء وتطبيق برنامج للتدخل المهني في الخدمة الاجتماعية يهدف إلى زيادة الكفاءة الاجتماعية والحد من الرهاب الاجتماعي لدى طالبات المرحلة الثانوية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:

١. التعرف على مستوى الرهاب الاجتماعي لدى طالبات المرحلة الثانوية قبل تطبيق البرنامج العلاجي.
٢. التعرف على مستوى الكفاءة الاجتماعية لدى طالبات المرحلة الثانوية قبل تطبيق البرنامج العلاجي.
٣. اختبار فاعلية برنامج التدخل المهني في خفض مستوى الرهاب الاجتماعي لدى أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.
٤. اختبار فاعلية البرنامج في رفع مستوى الكفاءة الاجتماعية لدى أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.
٥. الكشف عن الفروق في أبعاد الرهاب الاجتماعي والكفاءة الاجتماعية (المعرفية، السلوكية، الانفعالية) بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج العلاجي.

٧. الكشف عن طبيعة العلاقة الارتباطية بين درجات الرهاب الاجتماعي ومستوى الكفاءة الاجتماعية لدى طالبات المرحلة الثانوية.

### رابعاً: فروض الدراسة

انطلاقاً من أهداف الدراسة وتساؤلاتها، تم صياغة مجموعة من الفروض التي تسعى إلى التحقق من فعالية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية الكفاءة الاجتماعية وتخفيض مستوى الرهاب الاجتماعي لدى أفراد المجموعة التجريبية. ولتحقيق أغراض الدراسة بدقة، تم تقسيم الفروض إلى فروض رئيسة وفروض فرعية تغطي أبعاد المتغيرات موضوع البحث (المعرفي، والانفعالي، والسلوكي) على كل من مقياسي الكفاءة الاجتماعية والرهاب الاجتماعي، إضافةً إلى العلاقة الارتباطية بينهما في القياس البعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية.

### الفروض الرئيسية والفرعية للدراسة

#### الفرضية الرئيسية الأولى

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي على مقياس الكفاءة الاجتماعية، وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

ويتم التحقق من هذه الفرضية من خلال الفروض الفرعية الآتية:

**الفرضية الفرعية الأولى:** توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي في **البعد المعرفي** على مقياس الكفاءة الاجتماعية، وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

**الفرضية الفرعية الثانية:** توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي في **البعد الانفعالي** على مقياس الكفاءة الاجتماعية، وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

**الفرضية الفرعية الثالثة:** توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي في **البعد السلوكي** على مقياس الكفاءة الاجتماعية، وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

#### الفرضية الرئيسية الثانية

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي على مقياس **الرهاب الاجتماعي**، وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

ويتم التحقق من هذه الفرضية من خلال الفروض الفرعية الآتية:

**الفرضية الفرعية الرابعة:** توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي في **البعد المعرفي** على مقياس الرهاب الاجتماعي، وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

**الفرضية الفرعية الخامسة:** توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي في **البعد الانفعالي** على مقياس الرهاب الاجتماعي، وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

## مجلة الخدمة الاجتماعية

**الفرضية الفرعية السادسة:** توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي في **البعد السلوكي** على مقياس الرهاب الاجتماعي، وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

### الفرضية الرئيسة الثالثة

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسين **القبلي والبعدي** على مقياس الكفاءة الاجتماعية، وذلك لصالح القياس البعدي.

ويتم التحقق من هذه الفرضية من خلال الفروض الفرعية الآتية:

**الفرضية الفرعية السابعة:** توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في **البعد المعرفي** على مقياس الكفاءة الاجتماعية، وذلك لصالح القياس البعدي.

**الفرضية الفرعية الثامنة:** توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في **البعد الانفعالي** على مقياس الكفاءة الاجتماعية، وذلك لصالح القياس البعدي.

**الفرضية الفرعية التاسعة:** توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في **البعد السلوكي** على مقياس الكفاءة الاجتماعية، وذلك لصالح القياس البعدي.

### الفرضية الرئيسة الرابعة

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس الرهاب الاجتماعي، وذلك لصالح القياس البعدي.

ويتم التحقق من هذه الفرضية من خلال الفروض الفرعية الآتية:

**الفرضية الفرعية العاشرة:** توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في **البعد المعرفي** على مقياس الرهاب الاجتماعي، وذلك لصالح القياس البعدي.

**الفرضية الفرعية الحادية عشرة:** توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في **البعد الانفعالي** على مقياس الرهاب الاجتماعي، وذلك لصالح القياس البعدي.

**الفرضية الفرعية الثانية عشرة:** توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في **البعد السلوكي** على مقياس الرهاب الاجتماعي، وذلك لصالح القياس البعدي.

### الفرضية الرئيسة الخامسة:

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس الرهاب الاجتماعي، وذلك لصالح القياس البعدي.

ويتم التحقق من هذه الفرضية من خلال الفروض الفرعية الآتية:

**الفرضية الفرعية الثالثة عشرة:** توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين **البعد المعرفي** لمقياس الرهاب الاجتماعي و**البعد المعرفي** لمقياس الكفاءة الاجتماعية في القياس البعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية.

**الفرضية الفرعية الرابعة عشرة:** توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين **البعد الانفعالي** لمقياس الرهاب الاجتماعي والبعد الانفعالي لمقياس الكفاءة الاجتماعية في القياس البعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية.

**الفرضية الفرعية الخامسة عشرة:** توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين **البعد السلوكي** لمقياس الرهاب الاجتماعي والبعد السلوكي لمقياس الكفاءة الاجتماعية في القياس البعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية.

### خامساً: مفاهيم الدراسة

تُعَدُّ مفاهيم الدراسة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الإطار النظري للبحث، إذ تسهم في توضيح المصطلحات الرئيسة، وتحديد معانيها النظرية والإجرائية، مما يساعد على فهم العلاقة بينها وبين مشكلة الدراسة وأهدافها. وفي ضوء ذلك، تركز الدراسة الحالية على مجموعة من المفاهيم الرئيسة، هي: **الفعالية**، والتدخل المهني، والرهاب الاجتماعي، والكفاءة الاجتماعية، وذلك بهدف تحديد المقصود بهذه المفاهيم في سياق الدراسة، وضمان الدقة والوضوح في القياس والتحليل.

#### أ- مفهوم الفعالية

تُشتق الفعالية لغوياً من الفعل فعل، أي قام بالعمل وأحدث أثراً. وفي اللغة الإنجليزية تشير كلمة Effectiveness إلى القدرة على إحداث الأثر المطلوب وتحقيق الهدف، بينما تُستخدم كلمة Efficiency للدلالة على حسن استثمار الجهد والموارد. وتُستخدم الفعالية في العلوم الاجتماعية بمعنى الكفاءة، أي القدرة على تحقيق النتائج المرجوة وفق معايير محددة مسبقاً، وتزداد الفعالية كلما تحققت الأهداف بصورة أكثر اكتمالاً (أبو العلا، ١٩٨٢). وفي مجال الخدمة الاجتماعية، تُشير الفعالية إلى قدرة التدخل المهني على مساعدة العميل في تحقيق أهدافه خلال فترة زمنية محددة من الممارسة المهنية. (Richard, 1990)

**المفهوم الإجرائي:** تُستخدم الفعالية في البحث الحالي للدلالة على مدى قدرة برنامج التدخل المهني على خفض مستوى الرهاب الاجتماعي وتنمية الكفاءة الاجتماعية لدى طالبات المرحلة الثانوية المصابات بالرهاب الاجتماعي.

#### ب- مفهوم التدخل المهني

عرف التدخل المهني بأنه مجموعة من الخطوات المنظمة التي تقوم على أساس من الدراسة والبحث، وتتضمن هذه الخطوات والإجراءات خبرات الممارسة التي تناسب حل مشكلة معينة تواجه العميل (Huse & Cummings, 1985) كما يشار إليه باعتباره الفعل أو السلوك أو العمل الصادر من الأخصائي الاجتماعي الموجه إلى النسق أو أي جزء منه بهدف إدخال تغييرات عليه أو إحداث تغييرات فيه بحيث يكون هذا التدخل مبنياً على معارف الخدمة الاجتماعية ملتزماً بقيمتها وقد يكون هذا النسق فردياً أو جماعة أو مجتمع ويعتمد التدخل المهني على تقدير الموقف والتدخل والتقوى. (الفاروق، ١٩٨١) ويشير مصطلح التدخل المهني إلى الأنشطة العلمية المنظمة التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي والتي تتضمن الفهم الواعي للعميل كشخص في موقف اجتماعي بهدف الوصول إلى التغيير المطلوب في شخصيته وفي المواقف الاجتماعية المحيطة به بصورة متكاملة، ويعرف التدخل المهني أيضاً بأنه الجهود المنظمة للأخصائي الاجتماعي التي تستهدف زيادة قدرة العميل على فهم وتطبيق مبادئ وأسس حل المشكلة في مواجهة مختلف مشكلاته الحياتية مما يساعد على إعداده للتعامل بفعالية مع الصعوبات التي تواجهه في المستقبل (عبد المجيد، ٢٠١٠)

**المفهوم الاجرائي:** يقصد بالتدخل المهني في هذا البحث الأفعال المقصودة والمخططة التي تنفذها الباحثة من خلال البرنامج التدريبي الهادف إلى خفض مستوى الرهاب الاجتماعي وزيادة الكفاءة الاجتماعية لدى طالبات المرحلة الثانوية المصابات بالرهاب الاجتماعي.

### ج- مفهوم الكفاءة الاجتماعية

تُعد الكفاءة الاجتماعية أحد المفاهيم الأساسية في علم النفس والخدمة الاجتماعية، وتشير إلى قدرة الفرد على التفاعل الإيجابي مع الآخرين، وبناء علاقات اجتماعية ناجحة، والتكيف مع متطلبات المواقف الاجتماعية المختلفة. وتُعد الكفاءة الاجتماعية مؤشراً مهماً للصحة النفسية والتوافق الاجتماعي، إذ تعكس مستوى التفاعل البناء بين الفرد والجماعة، ولا تعتمد فقط على القدرات الشخصية، بل تتأثر بعوي الفرد بذاته وكيفية توظيف مهاراته في المواقف الاجتماعية (أبو مرق، ٢٠٠٨).

وتُعرف (Zhang & Hou, 2022) الكفاءة الاجتماعية بأنها بناء متعدد الأبعاد يشمل الجوانب المعرفية والانفعالية والاجتماعية، ويتكامل لإنتاج سلوكيات اجتماعية ملائمة ومقبولة. كما تشير الدراسات الحديثة إلى ارتباط الكفاءة الاجتماعية بقدرة المراهقين على إدارة التفاعلات الاجتماعية بفاعلية، مما يعزز توافقه النفسي والاجتماعي ويحد من المشكلات الانفعالية. **المفهوم الإجرائي:** تُعرف الكفاءة الاجتماعية في هذه الدراسة بأنها مجموع الدرجات التي تحصل عليها الطالبات عند الإجابة على مقياس الكفاءة الاجتماعية من إعداد الباحثة والمستخدم في الدراسة الحالية.

### د- مفهوم الرهاب الاجتماعي

وفقاً لدليل تشخيص الاضطرابات النفسية DSM-5-TR الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي (American Psychiatric Association, 2022)، يُعرف الرهاب الاجتماعي بأنه خوف أو قلق شديد ومستمر من موقف أو أكثر من المواقف الاجتماعية التي يكون فيها الفرد معرضاً لتدقيق الآخرين، ويخشى أن يتصرف بطريقة محرجة أو أن تظهر عليه أعراض القلق، مما يؤدي إلى تقييم سلبي من قبل الآخرين، وينتج عنه تجنب المواقف الاجتماعية أو تحملها بقلق شديد، وبدرجة تؤدي إلى خلل في الأداء الاجتماعي أو الأكاديمي أو المهني.

وفي السياق المحلي، يشير دليل المساعدة النفسية الصادر عن اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية بالمملكة العربية السعودية (٢٠٢٢) إلى أن الرهاب الاجتماعي يُعد من أكثر اضطرابات القلق انتشاراً، ويتجاوز الخجل العابر ليصبح معيقاً للعلاقات الاجتماعية والحياة اليومية.

**المفهوم الإجرائي:** يُعرف الرهاب الاجتماعي في هذه الدراسة بأنه مجموع الدرجات التي تحصل عليها الطالبات عند الإجابة على مقياس الرهاب الاجتماعي من إعداد الباحثة والمستخدم في الدراسة الحالية.

ملخص الدراسات السابقة التي تناولت الكفاءة الاجتماعية

## مجلة الخدمة الاجتماعية

| الباحث والسنة        | هدف الدراسة                                                             | المنهج والعينة           | أبرز النتائج                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| واصف (2024)          | خفض قلق التدريس والشعور بالخل عبر تنمية المهارات الاجتماعية             | تجريبي، (50) طالبًا      | فاعلية البرنامج في تحسين المهارات الاجتماعية وخفض القلق والخل مع استمرار الأثر |
| السيد (2023)         | تحسين الكفاءة الاجتماعية لدى أطفال التوحد باستخدام التكنولوجيا المساعدة | شبه تجريبي، (20) طفلًا   | فاعلية البرنامج في تحسين الكفاءة الاجتماعية                                    |
| زكي (2023)           | خفض القلق الاجتماعي وتنمية الكفاءة الاجتماعية لدى تلاميذ الابتدائي      | تجريبي، (25) تلميذًا     | تحسن دال في القلق الاجتماعي والكفاءة الاجتماعية واستمرار الأثر                 |
| معوض وآخرون (2021)   | تحسين الكفاءة الاجتماعية لدى المراهقين                                  | تجريبي، (30) مراهقًا     | فروق دالة لصالح القياس البعدي مع ثبات التحسن                                   |
| الجابري (2020)       | تنمية التكيف النفسي وتحسين الكفاءة الاجتماعية لدى العاملين              | شبه تجريبي، (30) عاملاً  | فاعلية البرنامج الانتقائي واستمرار أثره                                        |
| عبد النبي (2018)     | تحسين الكفاءة الاجتماعية وخفض الاغتراب لدى المراهقات الموهوبات          | تجريبي، (40) مراهقة      | فاعلية السيكدوراما والإرشاد الانتقائي والدمج بينهما                            |
| أبو العلا (2017)     | تنمية المهارات الاجتماعية لدى أطفال ذوي صعوبات التعلم                   | تجريبي، (20) طفلًا       | فروق دالة لصالح القياس البعدي واستمرار الأثر                                   |
| عثمان (2017)         | تحديد متطلبات تنمية الكفاءة الاجتماعية من منظور انتقائي                 | مسح اجتماعي، (62) طالبًا | التأكيد على السلوك التكيفي وتقدير الذات والرقابة الذاتية                       |
| Fatta et al. (2025)  | تنمية المهارات الاجتماعية لدى مراهقين مصابين بالتوحد                    | شبه تجريبي، (37) مراهقًا | تحسن ملحوظ في المهارات الاجتماعية وتنظيم المشاعر                               |
| Walder et al. (2025) | خفض القلق الاجتماعي عبر برنامج إلكتروني                                 | تجريبي، (133) مراهقًا    | تأثير إيجابي أوضح في القياس التتبعي                                            |

## مجلة الخدمة الاجتماعية

### ملخص الدراسات السابقة التي تناولت الرهاب الاجتماعي

| الباحث والسنة           | هدف الدراسة                                                       | المنهج والعينة                     | أبرز النتائج                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أبو عمر وآخرون (2022)   | خفض الرهاب الاجتماعي لدى طلاب الجامعة مضطربي الشخصية الاعتمادية   | المنهج التجريبي، (20) طالبة جامعية | فاعلية العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي في خفض الرهاب الاجتماعي مع استمرار الأثر في القياس التتبعي       |
| صديق (2022)             | خفض الرهاب الاجتماعي لدى المراهقين المتلعثمين                     | شبه تجريبي، (7) مرافقين            | فاعلية العلاج المعرفي السلوكي في خفض الرهاب الاجتماعي وتحسين التفاعل الاجتماعي مع حدوث انتكاسة بعد شهرين  |
| الجندي وتلاحمة (2021)   | خفض الرهاب الاجتماعي لدى طلبة المرحلة الأساسية العليا             | شبه تجريبي، (30) طالبا             | فاعلية كل من العلاج المعرفي السلوكي والتعرض للواقع الافتراضي مع تفوق البرنامج القائم على الواقع الافتراضي |
| علي (2021)              | خفض الرهاب الاجتماعي لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي | شبه تجريبي، (40) تلميذا            | فاعلية البرنامج القائم على اليقظة الذهنية في خفض الرهاب الاجتماعي مع استمرار الأثر بعد المتابعة           |
| عبد الراضي (2018)       | وصف أعراض الرهاب الاجتماعي لدى طلاب الثانوية العامة               | مسح بالعينة، (256) طالبا وطالبة    | ارتفاع الأعراض المعرفية للرهاب الاجتماعي لدى الإناث والتأكيد على الحاجة لتدخل مهني انتقائي                |
| الرشيد (2015)           | علاج الرهاب الاجتماعي لدى طالبات الجامعة                          | المنهج التجريبي، (30) طالبة        | فاعلية الإرشاد الانتقائي في خفض الرهاب الاجتماعي واستمرار التحسن ومنع الانتكاسة                           |
| Matsumoto et al. (2024) | علاج الرهاب الاجتماعي الإلكتروني عبر CBT                          | تجربة عشوائية محكمة متعددة المراكز | فاعلية العلاج السلوكي المعرفي عبر الإنترنت بنتائج علاجية مماثلة للعلاج التقليدي                           |
| Steele et al. (2025)    | علاج الرهاب الاجتماعي الإلكتروني قصير CBT عبر المدى               | تجربة عشوائية محكمة متعددة المراكز | الإلكتروني المكثف في CBT فاعلية خفض أعراض الرهاب الاجتماعي بنتائج مشابهة للتدخل التقليدي                  |

## الطريقة والإجراءات

تمثل هذه المرحلة الجانب التطبيقي من الدراسة، حيث تُترجم فيها الأهداف النظرية إلى إجراءات عملية يمكن من خلالها اختبار الفروض والتحقق من مدى صدقها. وتشمل الطريقة والإجراءات جميع الخطوات المنظمة التي اتبعتها الباحثة منذ اختيار مجتمع الدراسة وعينتها، مروراً بتحديد المنهج المناسب وأدوات القياس، وانتهاءً بتطبيق البرنامج العلاجي وتحليل نتائجه. ويُعد هذا الجزء من الدراسة الأساس الذي يُبنى عليه الحكم على مدى فاعلية التدخل العلاجي المقترح في تحسين الكفاءة الاجتماعية والتخفيف من الرهاب الاجتماعي لدى أفراد العينة.

### أولاً: منهج ونوع الدراسة

**نوع الدراسة** تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات شبه التجريبية التي هدفت لتعرف على فاعلية التدخل العلاجي (متغير مستقل)، في زيادة الكفاءة الاجتماعية لدى الطالبات المصابات بالرهاب الاجتماعي (متغير التابع).

**منهج الدراسة** اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي باستخدام تصميم المجموعتين المتكافئتين وذلك بتقسيم العينة إلى مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة. تم ضبط التصميم لضمان تكافؤ المجموعتين في درجات الاختبار القبلي، تم قياس الفروق في متوسطات الاختبار البعدي للمجموعتين. قد تعرضت المجموعة التجريبية للبرنامج العلاجي المقترح القائم على التدخل العلاجي الانتقائي التكاملي، بهدف الوقوف على مدى فاعليته في تنمية الكفاءة الاجتماعية والتخفيف من أعراض الرهاب الاجتماعي لدى أفرادها. ويمكن عرض تصميم منهج الدراسة كالتالي:

جدول (١) تصميم الدراسة للمجموعة التجريبية والضابطة

| المجموعة  | القياسين | المعالجة                                 | القياسين |
|-----------|----------|------------------------------------------|----------|
| التجريبية | القبلي   | برنامج التدخل العلاجي الانتقائي التكاملي | البعدي   |
| الضابطة   | القبلي   | لا يوجد                                  | البعدي   |

### الحدود الموضوعية للدراسة الأساسية:

تحددت الدراسة الحالية بموضوع أثر برنامج تدخل مهني في الخدمة الاجتماعية في تنمية الكفاءة الاجتماعية والحد من الرهاب الاجتماعي لدى طالبات المرحلة الثانوية، وذلك من خلال تطبيق مقياس الرهاب الاجتماعي ومقياس الكفاءة الاجتماعية على المجموعتين التجريبية والضابطة، وقياس التغير الناتج بعد تنفيذ البرنامج التدخلية.

### حدود أدوات الدراسة الأساسية:

اعتمدت الباحثة في دراستها على مجموعة من الأدوات التي تهدف إلى قياس متغيرات الدراسة الأساسية المتمثلة في **الرهاب الاجتماعي والكفاءة الاجتماعية**، وذلك قبل تطبيق البرنامج العلاجي وبعده، للتحقق من فاعليته. وتتمثل هذه الأدوات فيما يلي:

١. **مقياس الرهاب الاجتماعي:** أعدته الباحثة بالاستفادة من عدد من المقاييس والدراسات السابقة، وذلك لقياس مستوى الرهاب الاجتماعي لدى طالبات المرحلة الثانوية. ويهدف إلى التعرف على درجة معاناة الطالبة من القلق أو الخوف عند مواجهة المواقف الاجتماعية المختلفة. ويتضمن المقياس مجموعة من العبارات التي تقيس الأبعاد الانفعالية والمعرفية والسلوكية للرهاب الاجتماعي.
  ٢. **مقياس الكفاءة الاجتماعية:** أعدته الباحثة لقياس مستوى الكفاءة الاجتماعية لدى الطالبات، ويهدف إلى التعرف على مدى قدرة الطالبة على التفاعل الإيجابي مع الآخرين، وحل المشكلات الاجتماعية، والتعبير عن الذات بثقة. ويشتمل المقياس على مجموعة من العبارات التي تغطي الأبعاد المعرفية والانفعالية والسلوكية للكفاءة الاجتماعية.
  ٣. **البرنامج العلاجي الانتقائي التكاملي:** وهو البرنامج الذي أعدته الباحثة بالاعتماد على مجموعة من الأساليب العلاجية المعرفية والسلوكية والانفعالية، بهدف خفض مستوى الرهاب الاجتماعي وتنمية الكفاءة الاجتماعية لدى الطالبات من خلال جلسات علاجية مخططة ومحددة زمنياً.
- الحدود البشرية للدراسة الأساسية:**

### مجتمع الدراسة الأساسية :

جميع طالبات الصف الأول والثاني من طالبات المدرسة الثانوية الثانية بخليلص ممن أظهرت تقييمات المعلمات والاختصاصية الاجتماعية انهن يظهرن مظهر او اكثر من مظاهر الخجل اجتماعي أو ضعف في المهارات الاجتماعية ويحققن الشروط التالية:

١. أن تكون من طالبات الصفين الأول أو الثاني الثانوي
٢. أن تتراوح أعمارهن بين (20-15) سنة.
٣. أن يحصلن على درجة مرتفعة في مقياس الرهاب الاجتماعي ودرجة منخفضة في مقياس الكفاءة الاجتماعية.
٤. أن يكنّ من الطالبات المنتظمات دراسياً خلال فترة تطبيق البرنامج العلاجي.
٥. أن لا يكنّ قد شاركن في برامج علاجية أو إرشادية سابقة تتعلق بتنمية المهارات الاجتماعية أو خفض الرهاب الاجتماعي.
٦. أن يُبدن موافقة طوعية على المشاركة في الدراسة بعد توضيح أهدافها وضمان سرية بياناتهن.
٧. أن يتم الحصول على موافقة أولياء أمورهن للمشاركة في الدراسة.
٨. أن يتمتعن بصحة جسدية ونفسية جيدة تمكنهن من المشاركة بفعالية في البرنامج العلاجي.

### عينة الدراسة الأساسية

وتم تصنيف إجابات الطالبات التي حققنا الشروط وعددهن ٤٦ وقد جرى اختيار جميع الطالبات اللواتي حصلن على درجة مرتفعة في مقياس الرهاب الاجتماعي ودرجة منخفضة في مقياس الكفاءة الاجتماعية لتكوين العينة الأساسية وعددهن (٢٤) طالبة وتم تقسمهن عشوائياً الى مجموعتين على النحو التالي:

## مجلة الخدمة الاجتماعية

- **المجموعة التجريبية:** تضم (١٢) طالبة خضعن للبرنامج العلاجي الانتقائي التكاملي الذي أعدته الباحثة، والذي يهدف إلى خفض مستوى الرهاب الاجتماعي وتنمية الكفاءة الاجتماعية لديهن.
  - **المجموعة الضابطة:** تضم (١٢) طالبة لم يتلقين أي نوع من البرامج العلاجية خلال فترة تنفيذ الدراسة، واكتفت الباحثة بتطبيق أدوات القياس عليهن في فترات القياس نفسها التي طُبِّقت على المجموعة التجريبية، بهدف المقارنة بين المجموعتين.
- وقد روعي في عملية التقسيم **التكافؤ بين المجموعتين** من حيث العمر، والصف الدراسي، ومستوى الرهاب الاجتماعي والكفاءة الاجتماعية في القياس القبلي، لضمان دقة النتائج وصدقها العلمي.

### الحدود المكانية للدراسة الأساسية:

تحدد الحدود المكانية للدراسة في الأماكن التي تم فيها تنفيذ البرنامج العلاجي وجمع البيانات، وذلك على النحو الآتي:

١. المدرسة الثانوية الثانية بمحافظة خليص
٢. قاعة التدريب التابعة للجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة خليص
٣. منصة (Zoom)

### الحدود الزمانية للدراسة الأساسية:

تحدد الحدود الزمانية للدراسة خلال الفترة من 26 / 11 / 1446 هـ إلى 25 / 3 / 1447 هـ، وهي المدة التي تم خلالها تنفيذ مراحل الدراسة الميدانية.

### مخطط سير جلسات التدخل المهني

| عنوان الجلسة      | الأهداف                                                                                                                | عدد الجلسات | مدة الجلسة |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| الجلسات التمهيدية | - التعرف والتعاقد<br>- التعرف على البرنامج العلاجي<br>- التعرف على الرهاب الاجتماعي<br>- التعرف على الكفاءة الاجتماعية | ٢           | ساعة       |

## مجلة الخدمة الاجتماعية

|                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ٣٠ دقيقة              | ١٠ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- اطلاع الطالبات على أنماط التفكير الإيجابية والسلبية بشكل عام</li> <li>- تعريف الطالبات بأنماط التفكير الرهابية</li> <li>- مساعدة الطالبات على تحديد الأفكار الخاصة بهن الرهابية</li> <li>- توعية الطالبات بضرورة معالجة أفكارهن الرهابية</li> <li>- تعريف الطالبات بالكيفية التي تتم بها معالجة التشوهات المعرفية الرهابية</li> <li>- تنمية الحافز لدى الطالبات لمعالجة أفكارهن الرهابية</li> <li>- تدريب الطالبات على وضع خطة واضحة الأهداف والخطوات لمعالجة الأفكار الرهابية</li> <li>- تدريب الطالبات على كيفية موائمة أهدافهن لمعالجة أفكارهن الرهابية وفقا لقيمتهم واحتياجاتهن الشخصية</li> </ul>                                                             | جلسات العلاجية المعرفية   |
| ٣٠ دقيقة<br>-<br>ساعة | ٤  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- اطلاع الطالبات على أنماط السلوك الإيجابية والسلبية بشكل عام</li> <li>- تعريف الطالبات بأنماط السلوك الرهابية</li> <li>- مساعدة الطالبات على تحديد سلوكياتهن الخاصة الرهابية</li> <li>- توعية الطالبات بضرورة معالجة سلوكياتهن الرهابية</li> <li>- تعريف الطالبات بالكيفية التي تتم بها معالجة أنماط السلوك الرهابية</li> <li>- تنمية الحافز لدى الطالبات لمعالجة أنماط السلوك الرهابية</li> <li>- تدريب الطالبات على وضع خطة واضحة الأهداف والخطوات لمعالجة أنماط السلوك الرهابية</li> <li>- تدريب الطالبات على كيفية موائمة أهدافهن لمعالجة سلوكياتهن الرهابية وفقا لقيمتهم واحتياجاتهن الشخصية</li> </ul>                                                        | جلسات العلاجية السلوكية   |
| ساعة                  | ٦  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- اطلاع الطالبات على أنماط الانفعالات الإيجابية والسلبية بشكل عام</li> <li>- مساعدة الطالبات على تحديد الانفعالات المسببة للرهاب الاجتماعي</li> <li>- مساعدة الطالبات على تحديد انفعالاتهن الخاصة بهن المسببة للرهاب الاجتماعي</li> <li>- توعية الطالبات بضرورة معالجة انفعالاتهن الرهابية المسببة للرهاب الاجتماعي</li> <li>- تعريف الطالبات بكيفية معالجة أنماط الانفعال الرهابية</li> <li>- تحفيز الطالبات لإيجاد دوافع لمعالجة انفعالاتهن الرهابية</li> <li>- تدريب الطالبات على وضع خطة واضحة الأهداف والخطوات لمعالجة انفعالاتهن الرهابية</li> <li>- تدريب الطالبات على موائمة أهدافهن لمعالجة انفعالاتهن الرهابية وفقا لقيمتهم واحتياجاتهن الشخصية</li> </ul> | جلسات العلاجية الانفعالية |
| ٣٠ دقيقة              | ٢  | علاج التكميلي المساند ويشمل: العلاج بالأدوية- العلاجات بالمماثلة - النظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الجلسة الختامية           |

|                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الغذائي - العلاج بالفيتامينات والمكملات الغذائية                                     |  |
| علاج بالأعشاب - العلاج بالرياضة - العلاج بالروائح العطرية - العلاج التكاملي الإسلامي |  |
| - الجلسة الختامية                                                                    |  |

## ملخص نتائج الدراسة

### أولاً: ملخص نتائج مقياس الكفاءة الاجتماعية

- ١- **التكافؤ القبلي بين المجموعتين (قبل تطبيق البرنامج)**  
أظهرت اختبارات شايبرو-ويلك في القياس القبلي وجود انحراف عن الاعتدالية في عدد من المتغيرات، لذلك تم الاعتماد على الأساليب اللامعلمية للتحقق من تكافؤ المجموعتين. وباستخدام اختبار مان-ويتني لم تظهر فروق دالة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبلي على الأبعاد الفرعية لمقياس الكفاءة الاجتماعية (المعرفي، السلوكي، الانفعالي) ولا على الدرجة الكلية، حيث كانت قيم الدلالة جميعها أكبر من (٠.٠٥)، مما يؤكد تكافؤ المجموعتين قبل التدخل.
- ٢- **أثر البرنامج داخل المجموعة التجريبية (قبلي/بعدي)**  
أظهرت نتائج اختبارات (ت) للعينات المترابطة وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي لدى المجموعة التجريبية في جميع أبعاد الكفاءة الاجتماعية والدرجة الكلية، بما يدل على تحسن واضح بعد تطبيق برنامج التدخل المهني. كما جاءت أحجام الأثر مرتفعة جداً، مما يشير إلى تأثير قوي للبرنامج:  
  - البعد المعرفي: تحسن دال إحصائياً مع حجم أثر مرتفع. ( $\eta^2 = 0.94$ )
  - البعد السلوكي: تحسن دال إحصائياً مع حجم أثر مرتفع. ( $\eta^2 = 0.95$ )
  - البعد الانفعالي: تحسن دال إحصائياً مع حجم أثر مرتفع. ( $\eta^2 = 0.96$ )
  - الدرجة الكلية: تحسن دال إحصائياً مع حجم أثر مرتفع جداً. ( $\eta^2 = 0.97$ )
- ٣- **التغير داخل المجموعة الضابطة (قبلي/بعدي)**  
أظهرت اختبارات (ت) للعينات المترابطة عدم وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة الضابطة في الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية (جميع قيم الدلالة أكبر من ٠.٠٥)، مما يعني أن مستوى الكفاءة الاجتماعية لدى الضابطة لم يتغير جوهرياً خلال فترة الدراسة.
- ٤- **الفروق البعدية بين المجموعتين (بعد تطبيق البرنامج)** أثبتت النتائج وجود فروق دالة إحصائية في القياس البعدي بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية في جميع الأبعاد والدرجة الكلية، مما يؤكد فاعلية البرنامج مقارنة بعدم تلقي الضابطة للتدخل:

- البعد المعرفي: فروق دالة باستخدام مان-ويتني لصالح التجريبية مع حجم أثر كبير. ( $r = 0.74$ )
  - البعد السلوكي: فروق دالة باستخدام (ت) للعينات المستقلة لصالح التجريبية مع حجم أثر مرتفع. ( $\eta^2 = 0.95$ )
  - البعد الانفعالي: فروق دالة باستخدام مان-ويتني لصالح التجريبية مع حجم أثر كبير. ( $r = 0.84$ )
  - الدرجة الكلية: فروق دالة باستخدام مان-ويتني لصالح التجريبية مع حجم أثر كبير. ( $r = 0.83$ )
- ٥- نسبة التغير الفردي والكلية داخل المجموعة التجريبية أوضحت بيانات التغير الفردي أن التحسن شمل جميع الحالات في المجموعة التجريبية. فقد ارتفع متوسط درجات الكفاءة الاجتماعية من (37.33) في القياس القبلي إلى (68.00) في القياس البعدي، بمتوسط فرق بلغ (30.67) درجة، ونسبة تغير كلية بلغت (82.8%) كما تراوحت نسب التغير الفردية بين (61.9%) و\*\* (97.1%)\*\*، وهو ما يعكس اتساع التأثير الإيجابي للبرنامج وتحسن المشاركات بدرجات متفاوتة لكن في اتجاه واحد.

#### ثانياً: ملخص نتائج مقياس الرهاب الاجتماعي

##### ١- التكافؤ القبلي بين المجموعتين

أظهرت اختبارات شايبرو-ويلك في القياس القبلي أن جميع المتغيرات (الأبعاد المعرفي والسلوكي والانفعالي والدرجة الكلية) تتبع التوزيع الاعتدالي، كما أكدت مؤشرات الالتواء والتفلطح عدم وجود انحرافات معنوية عن الاعتدالية، مما سمح باستخدام الاختبارات المعلمية. وباستخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة لم تظهر فروق دالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي على أي بُعد أو على الدرجة الكلية (جميع قيم الدلالة  $> 0.05$ )، مما يؤكد تكافؤ المجموعتين قبل تطبيق البرنامج.

##### ٢- أثر البرنامج داخل المجموعة التجريبية (قبلي/بعدي)

أظهرت نتائج اختبار (ت) للعينات المترابطة وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي (أي انخفاض الرهاب) لدى أفراد المجموعة التجريبية في جميع أبعاد الرهاب الاجتماعي والدرجة الكلية، مع أحجام أثر مرتفعة تشير إلى قوة تأثير البرنامج:

- البعد المعرفي: انخفاض دال إحصائياً (ت=8.39،  $p < 0.001$ ) مع حجم أثر مرتفع. ( $\eta^2 = 0.86$ )
- البعد السلوكي: انخفاض دال إحصائياً (ت=13.38،  $p < 0.001$ ) مع حجم أثر مرتفع. ( $\eta^2 = 0.93$ )
- البعد الانفعالي: انخفاض دال إحصائياً (ت=16.81،  $p < 0.001$ ) مع حجم أثر مرتفع. ( $\eta^2 = 0.94$ )
- الدرجة الكلية: انخفاض دال إحصائياً (ت=16.99،  $p < 0.001$ ) مع حجم أثر مرتفع جداً. ( $\eta^2 = 0.95$ )

##### ٣- التغير داخل المجموعة الضابطة (قبلي/بعدي)

أظهرت اختبارات (ت) للعينات المترابطة عدم وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة الضابطة في الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية (جميع قيم الدلالة  $> 0.05$ )، بما يعني أن مستوى الرهاب الاجتماعي لدى الضابطة لم يتغير جوهرياً خلال فترة الدراسة.

##### ٤- الفروق البعدية بين المجموعتين (بعد تطبيق البرنامج)

أظهرت اختبارات الاعتدالية في القياس البعدي تحقق الاعتدالية في أغلب المتغيرات، باستثناء البعد المعرفي الذي استخدم معه اختبار لا معلمي. وقد كشفت النتائج عن فروق دالة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية (أي انخفاض الرهاب لديها مقارنة بالضابطة):

- البعد المعرفي (مان-ويتني): فروق دالة ( $p < 0.001$ ) لصالح التجريبية مع حجم أثر كبير ( $r = 0.85$ )
- البعد السلوكي (ت للعينات المستقلة): فروق دالة ( $p < 0.001$ ) لصالح التجريبية مع حجم أثر مرتفع ( $\eta^2 = 0.91$ )
- البعد الانفعالي (ت مع تصحيح Welch): فروق دالة ( $p < 0.001$ ) لصالح التجريبية مع حجم أثر مرتفع ( $\eta^2 = 0.93$ )
- الدرجة الكلية (ت للعينات المستقلة): فروق دالة ( $p < 0.001$ ) لصالح التجريبية مع حجم أثر مرتفع جداً ( $\eta^2 = 0.94$ )

### ٥- نسبة التغير الفردي والكلّي داخل المجموعة التجريبية

أوضحت نتائج التغير الفردي أن جميع أفراد المجموعة التجريبية شهدوا انخفاضاً في درجات الرهاب الاجتماعي بعد التدخل. فقد انخفض متوسط الدرجة الكلية من (66.17) في القياس القبلي إلى (35.25) في القياس البعدي، بمتوسط انخفاض بلغ (30.92) درجة، ونسبة تغير كلية بلغت (46.7%) كما تراوحت نسب التغير الفردية بين (30.5%) و (٦١.١%)\*\*، بما يعكس تأثيراً إيجابياً عاماً للبرنامج مع اختلاف مقدار الاستجابة بين الحالات.

### ثالثاً: ملخص نتائج اختبارات العلاقات بين الرهاب الاجتماعي والكفاءة الاجتماعية

أظهرت نتائج اختبارات الارتباط باستخدام معامل بيرسون وجود علاقات ارتباطية عكسية ودالة إحصائية بين درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي لمقياس الرهاب الاجتماعي ودرجاتهم في القياس البعدي لمقياس الكفاءة الاجتماعية، سواء على مستوى الأبعاد الفرعية أو الدرجة الكلية.

فعلى مستوى البعد المعرفي، كشفت النتائج عن علاقة ارتباطية عكسية قوية بين الرهاب الاجتماعي المعرفي والكفاءة الاجتماعية المعرفية، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط ( $r = -0.87$ ) وهي دالة إحصائية عند مستوى ( $p < 0.001$ )، وبلغ حجم الأثر ( $r^2 = 0.76$ )، مما يشير إلى أن نحو (٧٦%) من التباين في أحد المتغيرين يمكن تفسيره من خلال العلاقة مع المتغير الآخر. كما أظهرت نتائج البعد السلوكي وجود علاقة ارتباطية عكسية قوية جداً بين الرهاب الاجتماعي السلوكي والكفاءة الاجتماعية السلوكية، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط ( $r = -0.93$ ) عند مستوى دلالة ( $p < 0.001$ )، وبلغ حجم الأثر ( $r^2 = 0.86$ )، وهو ما يعكس قوة العلاقة وعمق الارتباط بين المتغيرين في هذا البعد.

وفيما يتعلق بـ البعد الانفعالي، فقد تبين وجود علاقة ارتباطية عكسية متوسطة بين الرهاب الاجتماعي الانفعالي والكفاءة الاجتماعية الانفعالية، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط ( $r = -0.65$ ) وكانت دالة إحصائية عند مستوى ( $p = 0.04$ )، وبلغ حجم الأثر ( $r^2 = 0.42$ )، مما يدل على أن قرابة (٤٢%) من التباين يمكن تفسيره من خلال العلاقة بين المتغيرين. أما على مستوى الدرجة الكلية، فقد أسفرت النتائج عن علاقة ارتباطية عكسية قوية بين الدرجة الكلية للرهاب الاجتماعي والدرجة الكلية للكفاءة الاجتماعية، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط ( $r = -0.88$ ) عند مستوى دلالة ( $p < 0.001$ )، وبلغ حجم الأثر ( $r^2 = 0.77$ )، وهو ما يعني أن ارتفاع مستوى الكفاءة الاجتماعية الكلية يرتبط بانخفاض واضح في مستوى الرهاب الاجتماعي الكلي.

## مجلة الخدمة الاجتماعية

وبناءً على ما سبق، تؤكد نتائج اختبارات العلاقات صحة جميع الفرضيات الارتباطية الفرعية والفرضية الرئيسة الثالثة، وتدعم الاتجاه القائل بأن تنمية الكفاءة الاجتماعية تُعد متغيراً مؤثراً بقوة في خفض مستويات الرهاب الاجتماعي لدى أفراد المجموعة التجريبية، ولا سيما في أبعاده المعرفية والسلوكية.

### المراجع:

- ابو العلا، نوال أحمد البدوي سيد. (2017). فاعلية برنامج إرشادي انتقائي لتنمية المهارات الاجتماعية للأطفال ذوي صعوبات التعلم في مرحلة الطفولة المتأخرة. مجلة دراسات الطفولة، مج ٢٠، ع ٧٧، ١٣٩-١٥١.
- أبو مرق، جمال. (2008). الكفاءة الاجتماعية وعلاقتها بالاتجاه نحو دمج المتفوقين والموهوبين في المدارس الحكومية من منظور طلبة جامعة الخليل. مجلة كلية التربية، (18)، ١١٤. 150-جامعة الخليل، فلسطين.
- عبد المجيد، فايزة يوسف. (2010). المهارات التوكيدية وعلاقتها بسلوك الإنجاز لدى عينة من أطفال الروضة. مجلة دراسات الطفولة، ١٣. (49) عين شمس، مصر: جامعة عين شمس.
- الفاروق، زكي يونس. (1981). الاتجاهات الحديثة في الخدمة الاجتماعية. المجلة العربية للعلوم الإنسانية، ١، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت.
- اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية. (2022). دليل المساعدة النفسية: اضطرابات القلق. المملكة العربية السعودية.
- **American Psychiatric Association.** (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). Washington, DC: Author.
- **Heimberg, R. G., & Holt, C. S.** (1997). Social anxiety disorder: A cognitive-behavioral perspective. In D. A. Hope (Ed.), *Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 44. Perspectives on anxiety, panic, and fear* (pp. 43-82). University of Nebraska Press.
- **Huse, Edgar F., & Cummings, Thomas G.** (1985). *Organization development and change* (3rd ed.). St. Paul, MN: West Publishing Company.
- **Richard, D., & McDonald, B.** (1990). *Behavioral psychotherapy*. Heinemann Medical Books.
- **Zhang, L., & Hou, Y.** (2022). Social competence and interpersonal functioning among adolescents. *Journal of Research on Adolescence*